

健康台灣 健保新政 總額改革與再升級

健康台灣論壇

衛生福利部中央健康保險署 陳亮妤副署長



陳亮妤副署長 M.D., PhD

獲獎與榮譽

國立成功大學醫學系優良校友，2023
臺北市醫師公會杏林獎，2022
科技部優秀年輕學者計畫得主，2019-2021
行政院全國反毒有功人士，2020
美國國家藥物濫用署正式會員，2017-
臺灣成癮科學會年度最佳論文獎，2015
第五屆亞洲精神醫學會 Sartorius 獎，2014
約翰霍普金斯 Phe Beta Kappa 榮譽會員，2014
約翰霍普金斯 Lucy Shum 精神醫學貢獻獎，
2014
約翰霍普金斯 Sommer 獎學金，2012-2014
公共服務 藥物濫用署性別差異研究獎，2012
臺灣精神醫學會秘書長 2021-2023
衛生福利部精神疾病防治諮議會委員 2021-2023
臺北市防疫委員 2021-2023
臺灣成癮醫學會理事 2020-2023
衛生福利部管制藥品委員會委員 2019-2023
新北市心理衛生諮議委員 2018



學歷：

美國約翰霍普金斯公共衛生博士
國立成功大學醫學系

報告大綱

1

多元財務 總額改革

2

888 計畫 慢病強化

3

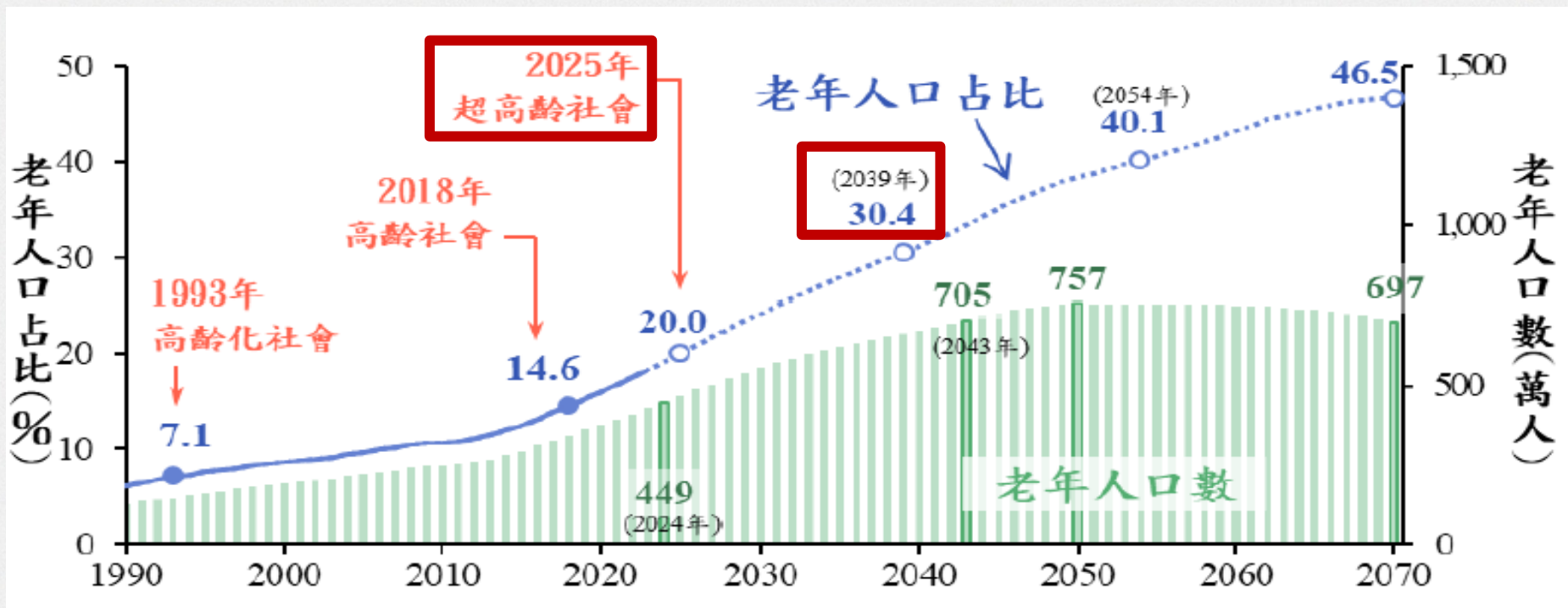
癌症治療 接軌國際

4

智慧醫療 健康台灣



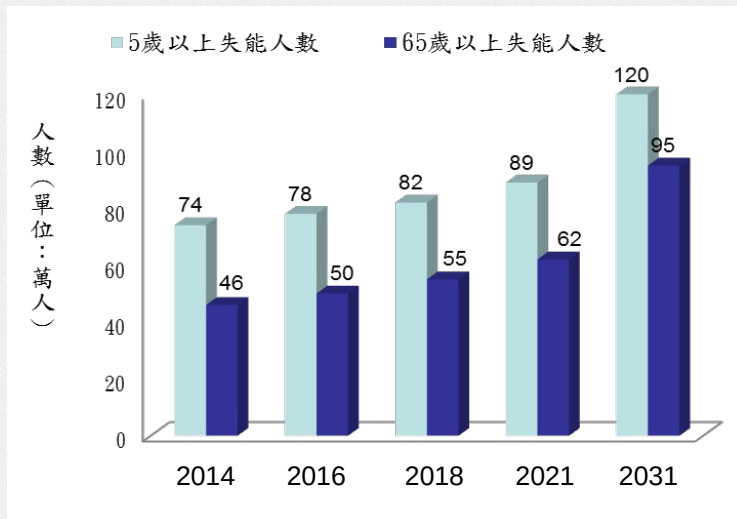
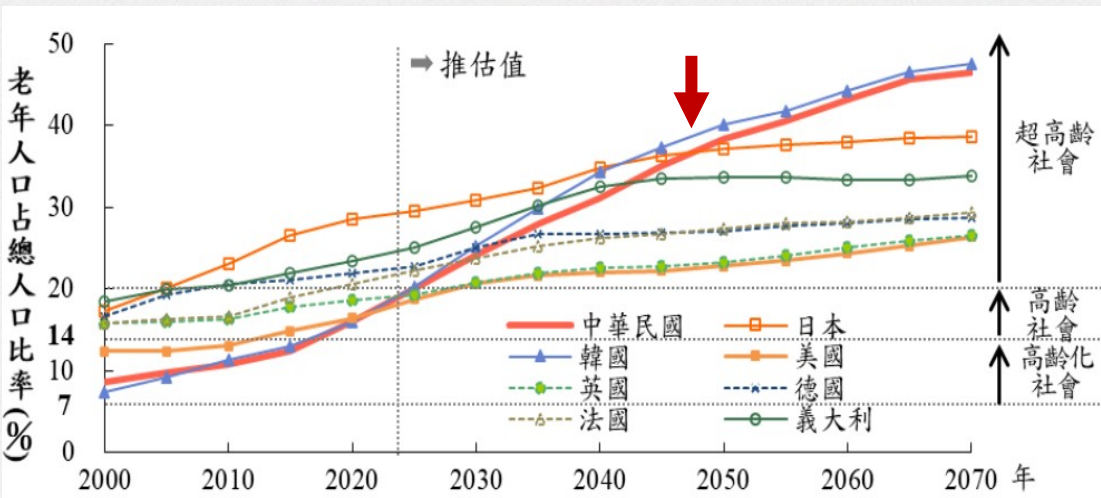
2025 實質邁入超高齡社會



資料來源：2023 年 (含) 以前實際值為內政部；2024 年 (含) 以後推估值為國家發展委員會「中華民國人口推估 (2024 年至 2070 年)」之中推估，2024 年 10 月。

老化速度領先各國 長照人口持續增加

- 人口快速老化，長照人口急速成長
 - 老化速度與韓國相近，較日本、歐、美各國快速
 - 2021 年全人口失能人數 89 萬人，2031 年增至 120 萬人



全人口失能率	3.28%	3.45%	3.63%	3.94%	5.30%
老人失能率	16.50%	16.19%	15.91%	15.60%	16.36%

註：1. 資料來源：「中華民國人口推估（2024 年至 2070 年）」之中推估，2024 年 10 月；衛生福利部國民長期照護需要調查，2010-2011 年。
2. 2022 年為各國實際值，2070 年為推估值

台灣醫療體系的挑戰

超高齡社會
老化速度遽升
在宅照護需求日增

慢性疾病負荷
癌症及三高病患
醫療保健支出增加

民眾賦能與賦權
強化自我健康管理
參與醫療決策



健保財務衝擊
新興科技發展迅速
新、癌、罕藥昂貴

人力短缺
少子女化影響
工作人口逐年下降

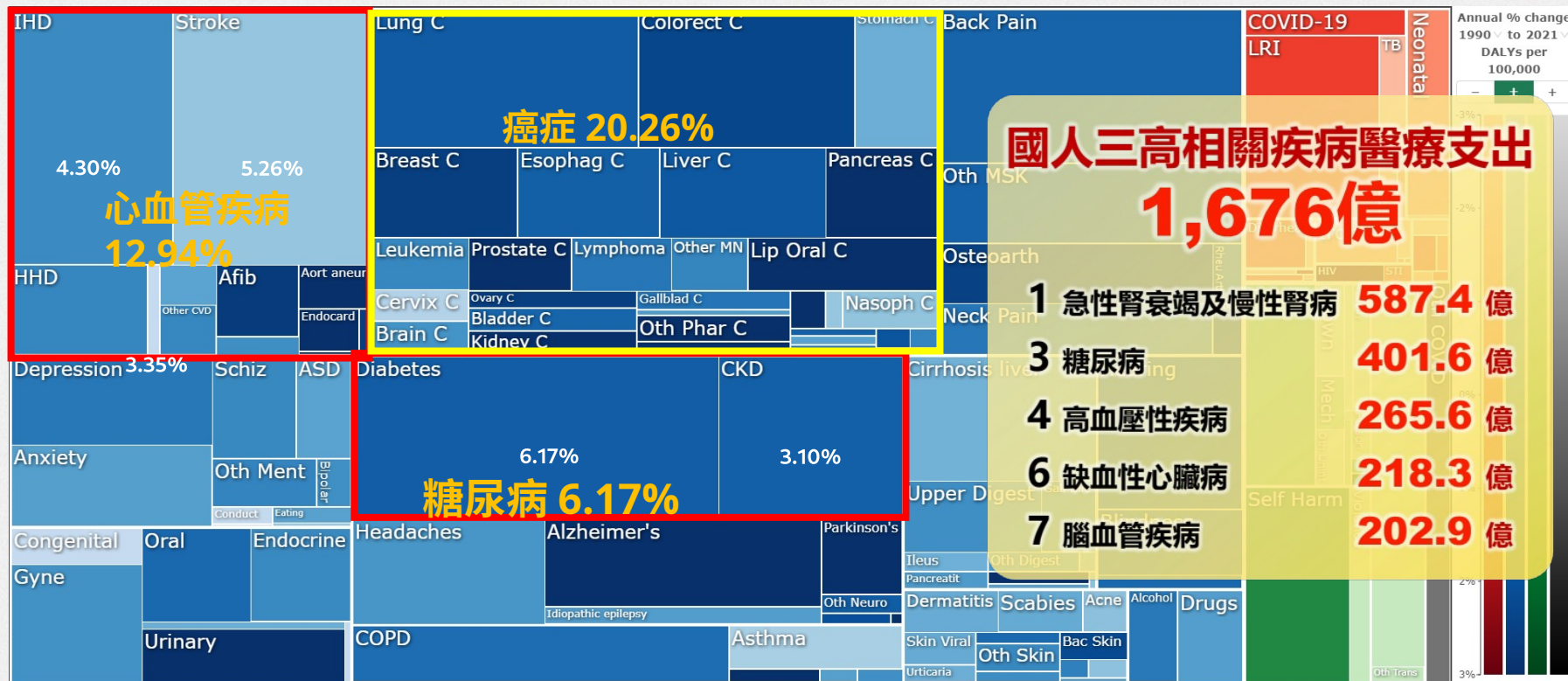
偏遠地理障礙
醫療資源分配不均
偏鄉就醫可近性低



癌症佔健保支出最高，心血管次之

癌症 20.26% 居冠，**心血管疾病 12.94%** 排第二、**糖尿病 6.17%** 第三

DALYs by Cause in Taiwan, 2021



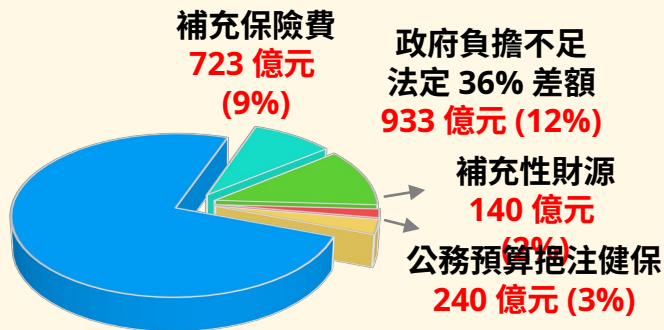
健保財務挑戰

收入面

人口高齡化少子女化 衝擊健保收入

112 年
保險收入

一般保險費
6,075 億元
(75%)



1

收入來源主要來自受薪階層
人口高齡化將加重工作人口負擔

2

補充保險費收費制度有改善空間
宜強化量能負擔公平性

3

費率調升不易，宜擴大計費基礎

支出面

藥費成長 醫療保健支出增加

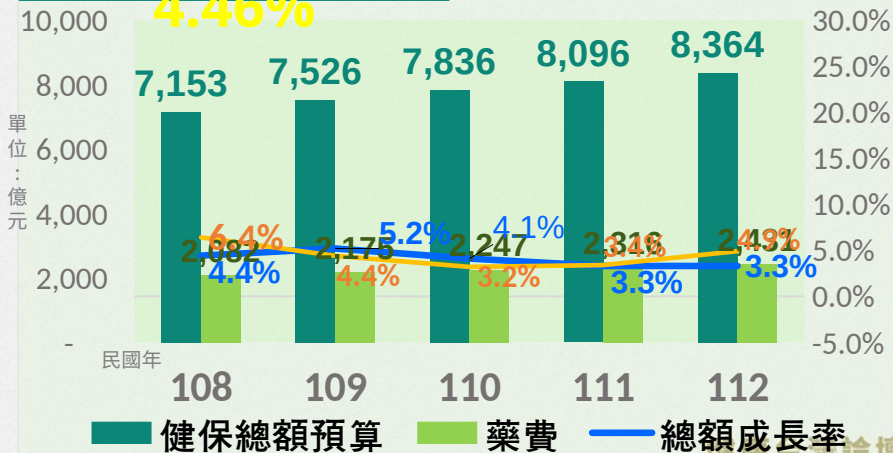
新型傳染病及疾病型態慢性化、新藥新特材持續導入、高齡社會造成就醫增加、物價上漲帶動醫療成本提升

近 5 年藥費平均成長率

4.46%

健保總額平均成長率

4.08%



註：藥費申報金額，未扣除藥品給付協議還款金額

114 年度健保財務成長 8.13%

健保總額成長
率（高推估）

較 113 年度增加
531 億元

總額移出
以公務預
算支應

114 年度新增預算
111 億元

癌症新
藥專款

114 年度新增預算
50 億元

額外挹
注罕病
用藥專
款

114 年度新增預算
20 億元

公務預算挹注 181 億

114 年度總額成長達 **9286 億元**，較 113 年總額 (8755 億) 增加 **531 億元**，實質成長率為 6.06%；
若加計公務預算 181 億，則增加 **712 億元**，實質成長率則達 **8.13%**。

註：114 年度政府健保財務協助方案預算共達 335.6 億元

停復保制度走入歷史 年增 24 億

「停復保」 12月23日失效 健保估增24億收入

2024-11-23 01:00 聯合報／記者李青紫／台北報導



取消健保停復保制度最新說明！徐佳青邀健保署直播解惑

發稿時間：2024/12/30 16:37:13

(中央社訊息服務20241230 16:37:13)



僑委會委員長徐佳青(右)邀請健保署副署長陳亮妤(左)直播說明健保停復保規定變革

急重症加給付年增 42 億。

健保砸逾42億解急診壅塞 護理加薪4提案通過拚
5月上路

2025/3/12 21:16 (3/12 21:26 更新)



- 離島所有急診案件給付調升 10%
- 離島中度急救責任醫院增加 30%
- 離島重度急救責任醫院調升 50%
- 急診醫師診察費和護理費各調增 10%
- 觀察床護理費調升 60% 。
- 全重度級的急救責任醫院，加護病房給付比照醫學中心；中度級急救責任醫院則比照區域醫院。

合理醫療給付 促進支付衡平性

合理反應醫療服務成本、醫事人力及資源耗用

支付標準 4,843 項

西醫基本診療 312 項

特定診療 3,995 項



相關醫學會

討論支付標準調整方案



規劃辦理專家會議

精進支付制度



依預算額度陸續調整

支付標準反應，合理給付



➤ 100 年 RBRVS 結果，推估調整支付標準約需 **400 億點**

➤ 優先調升基本診療點數、特定診療項目點數、提升兒童加成、提升急診加成等

➤ 優先調升**醫事人力**為主及**急重難罕症**項目給付

➤ 規劃調整「**醫院**」之初、複診診察費將「**看診時間**」、「**病人病情嚴重度**」納入考量

報告大綱

1

多元財務 總額改革

2

888 計畫 慢病強化

3

癌症治療 接軌國際

4

智慧醫療 健康台灣



近十年慢性病就醫人數及費用占率

近十年慢性病就醫人數自 1,029.7 萬人 (103 年) 成長至 **1,336 萬人** (112 年)
 慢性病費用占整體健保支出則自 41.3%(103 年) 成長至 **48.9%**(112 年)



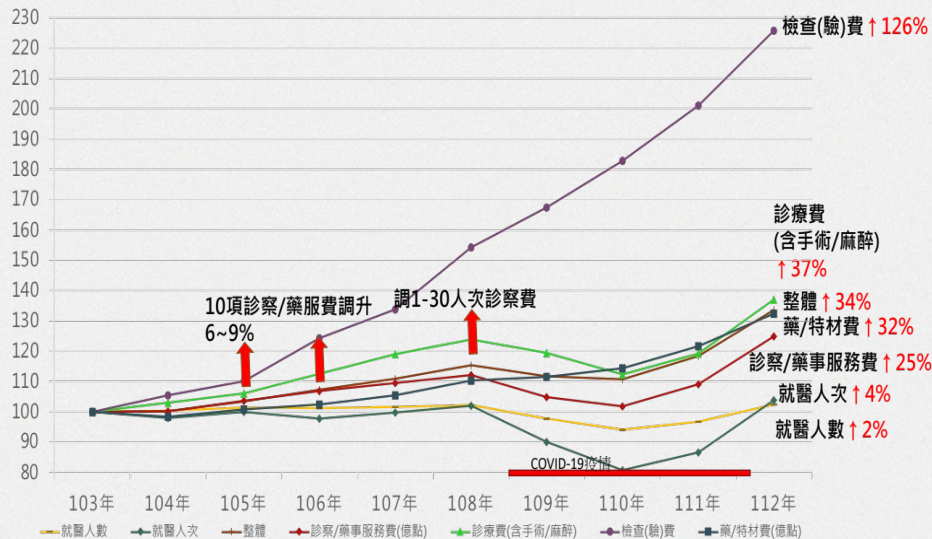
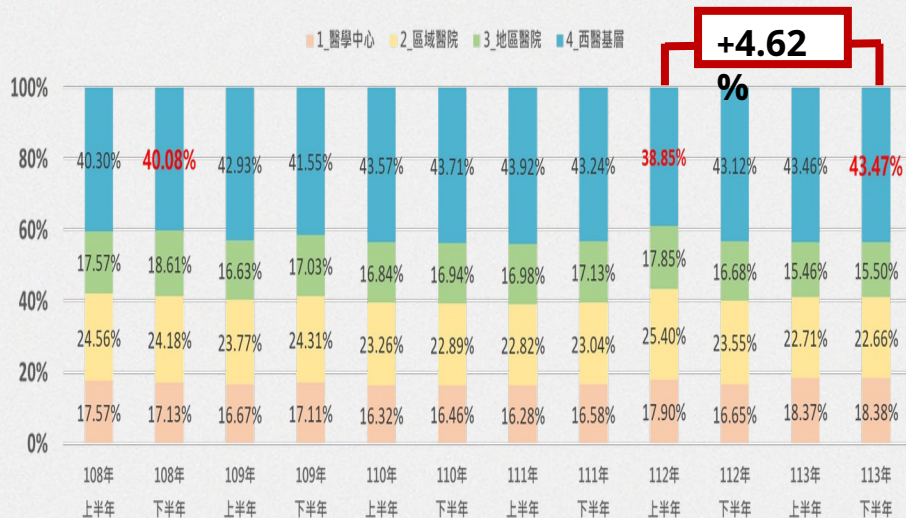
慢性病案件定義如下：

- 門診：案件分類為慢性病 (04,24)、透析 (05)、結核病 (06)、慢箋箋調劑 (08,28)、支付制度試辦計畫 (E1)、愛滋病慢箋 (E2,E3) 或開藥天數大於 14 日。
 - 住院：主診斷為全民健康保險醫療辦法規定得開立慢箋之「全民健康保險慢性疾病範圍」
- 排除代辦案件，且人數以 ID,BIRTHDAY 歸戶後統計

後疫情時代：慢性病流向基層醫療

113 年下半年慢性病人至西醫基層就醫件數占率，較 112 年上半年增加 **4.62%**，超過疫情前同期占率

西醫基層醫療分項費用_相較 103 年**檢查費、診療費**上升大於整體費用成長



- 資料來源：多模型健保資料平台門診、交付機構及住院明細檔。(擷取日期：114年2月3日)
- 統計範圍：門診醫院、西醫基層總額部門(不含門診透析)案件。
- 本表排除重大傷病登記係申報部分負擔代碼 001、011、012、013 之案件
- 慢性病係指(原)案件類別為 04、05、06、08、E1、E2、E3 或給藥天數>14 天之案件；並排除「接受其他院所委託代(轉)檢案件且未申報費用者」、「慢性病連續處方箋調劑」、「病理中心」、「交付機構」。



健康台灣 / 希望工程 - 三高防治 888 計畫



2024 賴清德
國家希望工程
National Project of Hope

健康台灣論壇

打造台灣成為健康幸福的國家

123	通過健康憲章	678	擴大心理健康支持
45	健康台灣深耕計畫	9	強化「國家癌症防治計畫」
	8 年 888 計畫		強化原住民族健康服務
	改善醫療人員工作環境， 強化醫事人力增補		智慧醫療結合健康照護， 推動生醫產業
	確保健保永續經營	10	長照 3.0

123	改善醫療人員工作環境	678	百億癌症新藥基金
45	增加心理健康支持	9	多元財務管道增加健保總額
	培養國人營養及愛好運動習慣		加速智慧醫療與健康照護結合
	8 年 888 計畫		檢討公醫薪資結構
	提供重要癌症篩檢率	10	長照 3.0

8 年 888 計畫政策目標

- (一) 80% 三高、心腦血管疾病、CKD 病人加入共照網
- (二) 80% 共照網病人，接受生活習慣諮商
- (三) 80% 共照網病人，達到三高控制

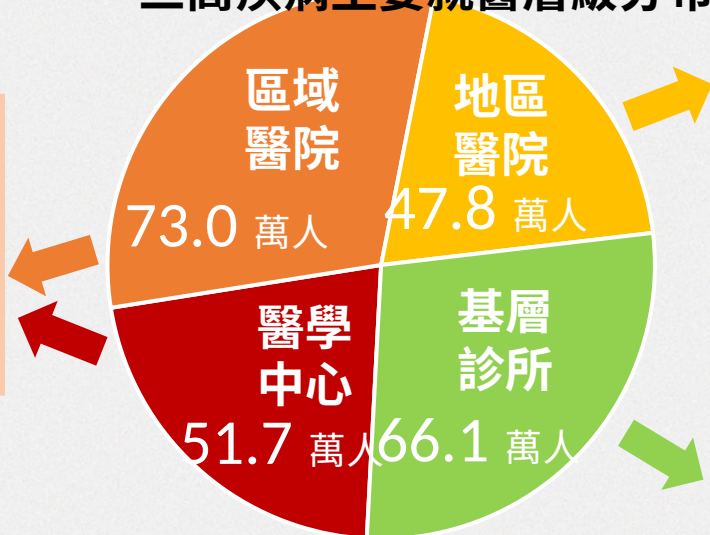
延緩慢病惡化、失能
提升國人健康餘命

大家醫平台 - 擴大服務涵蓋率

112 年約 534 萬名三高患者，**113 年已有 315 萬人 (59%)** 已接受家醫計畫、代
謝症候群防治計畫、P4P-DM/CKD/DKD、**全人全社區照護計畫**相關照護

未參與任一計畫對象中 (233 萬人) 之
三高疾病主要就醫層級分布

公私協力、接軌國際，**透過
AI 疾病嚴重度分級**，疾病嚴
重度高者，由區域級以上醫
院收案



113 年辦理**地區醫院全人全
社區照護計畫**，逐步將三高
疾病高風險族群納入照護

交由家醫計畫收案，
並推行**家醫計畫 2.0**



導入生活習慣諮商，有效控制慢性疾病病程發展

生活型態醫學

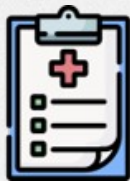
使用實證有效的生活型態，包括營養、運動、睡眠、壓力管理、避免使用高危害性物質、正向社會連結，由接受過訓練的臨床醫師提供介入，以預防、治療，並逆轉慢性疾病。



Making the Case for Lifestyle Medicine
Susan Benigas, BS; Dexter Shurney, MD, MBA, MPH, FACLM,
DipABLM; Ron Stout, MD, MPH, FACLM, FAAFP
doi:10.12788/jfp.0296

健康台灣 - 三高防治 888 政策，規劃將**生活習慣諮商**導入**全人全社區照護計畫**及**家醫計畫**，藉由醫療團隊介入，改變病人生活方式，有效控制慢性疾病病程發展

Step 1：病人個人健康資料建檔



- ✓ 參採生活型態醫學會 - 生活型態評估量表，**收載生活型態醫學的各領域評分**，以協助醫師後續進行生活習慣諮商及訂定計畫

Step 2：提供生活習慣諮商



- ✓ 與國健署、學協會共同**研議生活習慣諮商推動計畫**，**規劃導入 114 年家醫計畫及全人全社區照護計畫**

生活習慣諮商改善長者安眠藥使用

提升全人全社區照護 健保署：生活諮商指標明年上路

2024-12-08 20:43 聯合報／記者沈能元／台北即時報導

+ 失眠



陳亮妤指出，分析安眠藥用藥情況，各年齡層用藥量均上升，六十五歲至九十歲為主要用藥族群，去年六十五至六十九歲使用安眠藥人數高達廿四萬人，其次為六十至六十四歲廿三點一萬人、七十至七十四歲廿二點一萬人。

開立安眠藥科的醫療科別，以精神科為主，其次為家醫、內科、心臟血管內科及神經科。

陳亮妤表示，許多三高患者合併慢性失眠，希望透過「生活習慣諮商」，病人能透過衛教指導，由醫師填寫病人生活習慣評估量表，以期健康生活正、降低多重用藥。

報告大綱

1

多元財務 總額改革

2

888 計畫 慢病強化

3

癌症治療 接軌國際

4

智慧醫療 健康台灣





2024.4.27

總統健康台灣醫療政策及
健康台灣論壇建言及倡議

- ▶ 由下而上
- ▶ 公私協力
- ▶ 跨域合作

癌症治療三箭



強化國家癌症防治計畫



2030 年癌症死亡降低 1/3

- 1 提升早期癌症篩檢
- 2 聚焦基因檢測與精準醫療
- 3 建立百億癌症新藥基金

國家癌症防治策略 強化精準醫療

健康促進

- 菸害防制
- 檳榔防制
- 酒癮治療
- 運動促進
- 國民營養
- 生活習慣

實證篩檢

- BC 肝篩檢
- 四癌篩檢
- 低劑量電腦斷層 LDCT
- 幽門螺旋菌篩檢
- 共病篩檢

預防性治療

- B 肝治療
- C 肝治療
- 幽門螺旋菌消除 *

* 健保自 113.8.1 起給付
C¹³ 吹氣或糞便篩檢陽性
之除菌治療

早期診斷

- 健保癌症治療品質改善計畫 (陽追)
*自 114 年起，移由公務預算支應
- 肺癌篩檢疑似異常個案追蹤

精準治療

- 基因檢測
- 標靶藥物
- 免疫療法
- 微創手術
- 精準放療
- 乳癌論質計酬計畫

國民健康署 (公務預算及菸金)

中央健康保險署 (健保基金預算)

提升早期癌症篩檢

癌篩

癌症篩檢擴大服務對象

2025 年總計 68 億

- ✓ **大腸癌**：原50-74歲→45至74歲、40-44歲具家族史
- ✓ **子宮頸癌**：原≥ 30歲→ ≥ 25歲女性
- ✓ **乳癌**：原45-69歲→40至74歲女性
- ✓ **肺癌**：重度吸菸者(≥ 30包年→≥ 20包年吸菸史)及家族史
- ✓ **胃癌**：擴大全國45-74歲辦理幽門桿菌糞便抗原檢測

調高篩檢費用

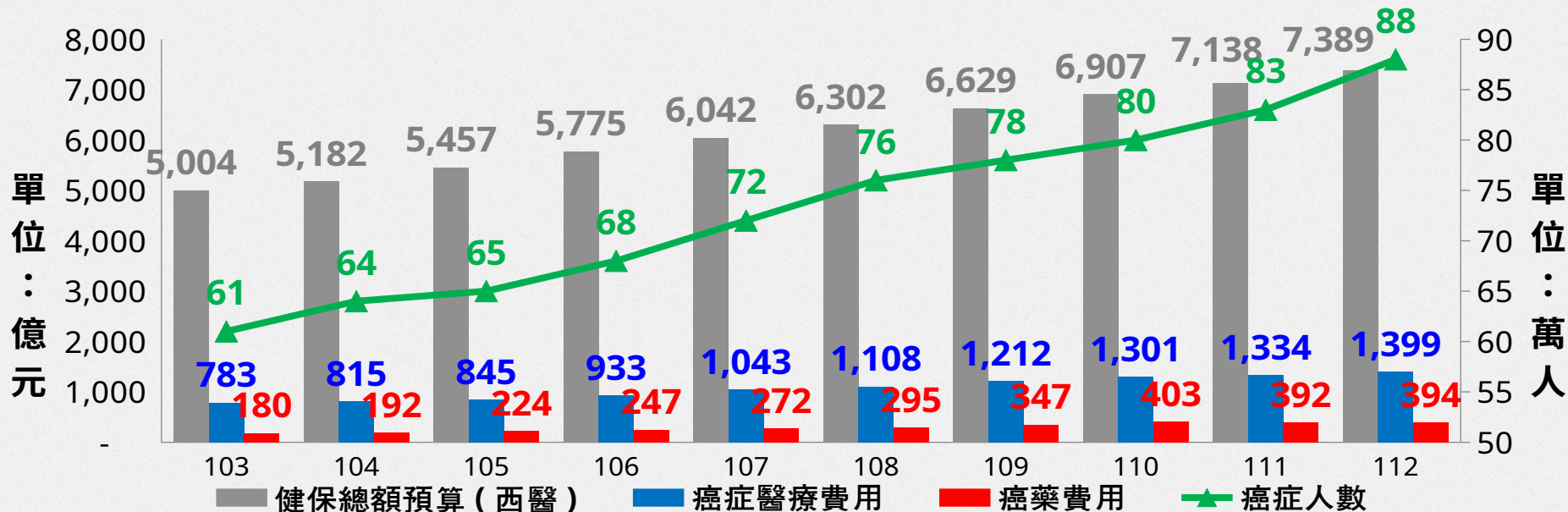
- ✓ **大腸癌**：200→400 元 / 案
- ✓ **子宮頸癌**：430→630 元 / 案
- ✓ **口腔癌**：130→250 元 / 案

新增篩檢工具及服務

- ✓ **HPV 檢測服務**：35 歲、45 歲、65 歲

癌症治療與癌藥費用快速成長

112 年癌症就診病患達 **88 萬人**，癌症醫療花費 **1,399 億元**
 癌藥費用支出達 **394 億元 (28.2%)**，103-112 年癌藥費用平均成長率 **9.3%**



說明：1. 癌症人數、醫療費用及癌藥費用資料來源為 DA 醫療給付檔案分析系統 / 藥品監測報表

2. 癌症醫療費用及癌症人數係主次要診斷碼符合癌症 (C00-C97) 者之費用及人數合計

3. 癌藥費用係主次要診斷碼符合癌症 (C00-C97) 者，且 ATC 碼前三碼符合各項癌症用藥之藥品申報金額合計

4. 健保總額預算係採每年醫院部門及西醫基層部門總額核 (決) 定結果

5. 所有藥費及癌藥費用尚未扣除廠商還款

癌症治療加速接軌國際

- 邀集相關領域專家就主要癌症擬訂治療指引與策略，逐步補強癌症治療缺口
- 優先接軌 NCCN 國際治療指引 category1 及 preferred treatment**

規劃

盤點健保用藥與國際治療差異

- 逐步盤點**乳癌、肺癌、大腸癌**等重大癌症健保給付藥品及範圍與國際指引及 3 大 HTA 組織差異。

召開專家會議

- 邀集醫藥專家就**治療缺口及參考 HTA 成本效益**，提供**治療策略及給付規定修訂建議**。

補強癌症治療缺口

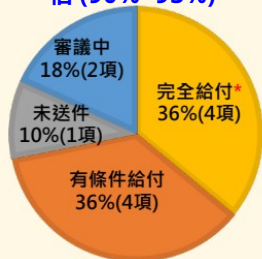
- 依**給付建議**提請專家會議審查及共擬會議審定。

113 年接軌 NCCN 國際治療指引具體成效

肺癌：第四期存活率僅 13.1%，接軌 NCCN 國際治療指引 category1 及優先建議，改善晚期預後。

非小細胞肺癌(共11項)

佔 (90%~93%)



小細胞肺癌(共3項)

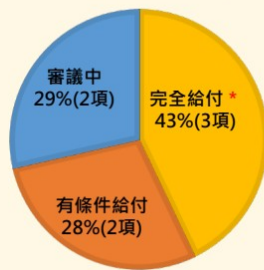


*完全給付：依藥品許可證給付

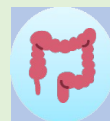
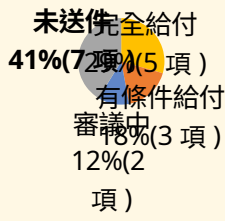
乳癌：接軌 NCCN 國際治療指引 category1 及優先建議，改善早、晚期治療及預後。

早期乳癌(共7項)

晚期乳癌(共17項)



*完全給付：依藥品許可證給付



轉移性大腸直腸癌
NCCN 國際治療指引缺口藥物，改善預後。

健保已給付轉移性大腸癌第一、三、四線標靶藥品

補足第二線治療缺口！

【審議中藥品】

encorafenib、
bevacizumab、
pembrolizumab(IO)

設立醫療科技評估之專責辦公室



CHPTA 專責辦公室

Center for Health Policy and Technology Assessment (CHPTA)

健康政策與醫療科技評估中心

112 年 12 月 27

揭牌啟動典禮

113 年 1 月 1 日

成立專責辦公室

✓ 使命：

- 1) 強化藥品給付審查及平行送審機制。
- 2) 協助暫時性支付之推動規劃。
- 3) 推動行政法人設置規劃。

✓ 任務：

- 1) 辦理醫療科技評估 (HS、HTA 及 HTR)。
- 2) 新醫療技術、藥品及醫材給付審查。
- 3) 藥物經濟學評估。
- 4) 法規研析及政策評估。
- 5) 人才培訓與國際合作。



癌症新藥基金：台灣的射月計

賴總統：癌藥基金不只畫意

已找到財源！射月計畫不能沒有火箭，癌症死亡率2030拚降低三分之一

2024.11.20 / 03:00 / 工商時報 呂雪慧



他強調，在選舉政見時曾提及要建置百億癌症新藥基金，惟 100 億元只是一個說法，用完還是會再補充，他透露已經找到財源，**並非總計只有 100 億元額度可用**，「這是癌症的射月計畫，不能沒有火箭。」

報告大綱

1

多元財務 總額改革

2

888 計畫 慢病強化

3

癌症治療 接軌國際

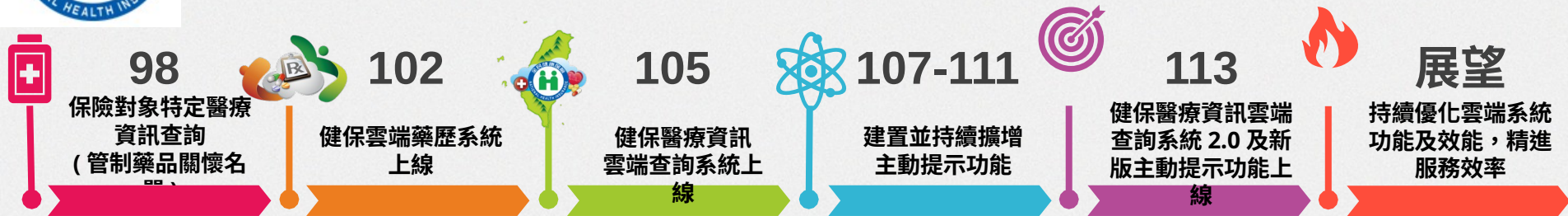
4

智慧醫療 健康台灣





善用健保大數據結合資訊科技



健保特約院所



HIS

多元認證
健保 VPN



輔助診療



醫療服務



健保醫療資訊
雲端查詢系統

2.0

113.4.17 上線

主動
提示機制

- 過敏藥物
- 藥品交互作用
- 潛在 C 肝病人追蹤
- NSAIDs 用藥及腎功能

新版 113.6.17 上線

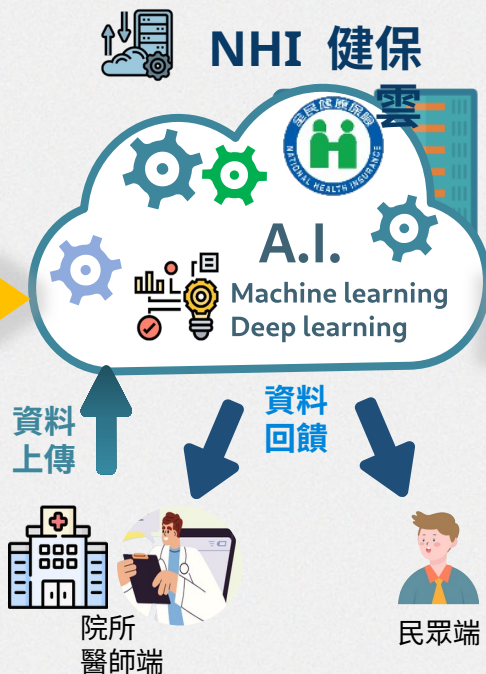
運用 AI 依風險分級分流

透過公私協力，逐步**建構疾病風險分級 (糖尿病、ASCVD)**及預測模型開發，導入**大家醫平台**，以創新模式建構以民眾為中心的**整合式全人全程健康照護**

數據輸入 健保資料庫

- ☑ 性別
- ☑ 年齡
- ☑ 共病
- ☑ 家族病史
- ☑ 社經資訊
- ☑ 風險因子
- ☑ 檢查檢驗數據
- ☑ 穿戴式裝置或自行上傳資訊等

- ☑ ICD-10 Code
- ☑ (aDCSI 7 大類合併症 /52 個亞型)



數據輸出 預測結果

罹病前

未來發生糖尿病之風險預估

- 1) 10 年內
- 2) 5 年內
- 3) 1~3 年內

罹病後

糖尿病合併症分級 (分 6 等級)

導入後關鍵指標

- 1) 總住院率
- 2) 特定原因住院率
- 3) 死亡率
- 4) 慢性病罹病率
- 5) 醫療費用

家醫大平台 依風險**分流照護** 分級獎勵

分 6 等級

- 綠色：低風險
- 黃綠色：有風險
- 黃色：中風險
- 黃橙色：中高風險
- 紅橙色：高風險
- 紅色：嚴重風險

分流照護

門診、衛生所

地區醫院

區域醫院

醫學中心



推動基層院所 HIS 雲端數位轉型

- ▶ 數產署與本署合作於 113 年推動「診所雲端系統研發計畫」
- ▶ 本署將持續擴大基層院所完成 HIS 系統雲端轉型，補助 8 億

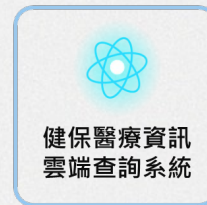
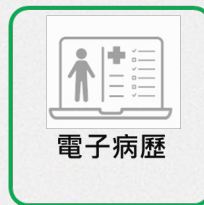
計畫名稱 基層院所醫療資訊系統 (HIS) 雲端轉型補助計畫

執行期間 114 年起

補助方式 依轉型方案及轉型家數給予**資服廠商**補助費用

推動家數 114 年以**西醫為主**，中醫 / 牙醫 / 藥局為次

雲端轉型功能項目



本署重要政策功能

開放偏鄉離島遠距醫療 - 強化健康平權

遠距醫療給付計畫

◆ 執行現況：

- 醫師對醫師 (B2B) 遠距會診模式
- 已提供 59 個鄉鎮及 11 個急重症轉診網絡遠距會診服務共 121 家在地院所與 50 家遠距院所，服務總人次約 14,603 人次。
- 同年 8 月 27 日起，擴大適用醫療資源缺乏地區及矯正機關。

項目			111年	112年	113年 1-11月
專科門 診遠距 會診	論服 務量	服務人數	1,881	2,851	3,748
		服務人次	3,446	4,958	6,811
	論診 次	開診數	637	624	651
		服務人次	2,845	3,034	5,100
急診遠距會診		服務人數	85	844	2,643
		服務人次	85	858	2,692



專科門診遠距會診

眼科、耳鼻喉科、皮膚科、心臟內科、
胃腸科、神經內科、胸腔科、精神科
(限矯正機關)



急診會診



醫師
(遠距端)

打造就醫全流程數位化 破除空間限制

目標

- ▶ 推動雲端病歷與虛擬健保卡、電子處方箋，將有利於遠距、居家、偏鄉、行動醫療等服務。
- ▶ 數位身分認證機制，提供民眾**更便利的就醫方式**，邁向數位醫療照護服務新時代

申請虛擬健保卡

線上申請
逐案審核

就醫

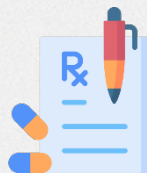
功能強化

交付處方

電子處方箋
結合數位簽章

繳費

介接
院所線上支付



透過授權同意進行
掛號、看診、領藥
等程序

處方箋交付調劑
或配合藥師送藥
服務

醫指付、街口支
付、阿佩 (APAY)
支付



視訊看診 X 雲端 HIS X 線上刷卡支付

健康台灣 健保改革藍圖

1. 優化健保財務

- ▶ 擴大政府投資及財源
- ▶ 研擬改革補充保費
- ▶ 研議**健保協同商保**

3. 普及醫療服務

- ▶ 持續擴大偏遠地區遠距醫療服務。
- ▶ 逐步推廣偏鄉**全人全家全社區照護計畫**。
- ▶ 搭配醫療網，保障**燈塔型醫院營運**，維持各專科服務量能。

5. 精準癌症防治

- ▶ 落實**精準癌症防治三箭**，**百億癌症新藥計畫**。
- ▶ 建構**精準健康生態系**。

2. 強化慢病照護

- ▶ 推動大家醫計畫，落實 **888 慢性病照護目標**。
- ▶ 檢討健保**居家醫療計畫**，無縫銜接長照服務。

4. 改革藥品政策

- ▶ 檢討健保 DET 政策，強化藥品供應韌性。
- ▶ 加速**新藥、新科技**導入健保體系。
- ▶ 成立**行政法人國家醫療科技評估中心**，以實證基礎 (HTR)，檢討藥品及特材給付。

6. 醫療數位升級

- ▶ 推動健康平權健保數位升級計畫。
- ▶ 公私協力營造**智慧雲端服務**。

Health for All



健康台灣論壇

感謝聆聽

